



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : سماء علاء الدين عبدالمجيد حسن
المحافظة : الجيزة الحى / المدينة : الهرم

العنوان : -----

تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

رقم البطاقة : 29005272100781 رقم التليفون : 01149777205

العمر (تاريخ الميلاد) : 27-05-1990 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: ----- التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : ----- قسم : -----
جهة العلاج : ----- نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سماء علاء الدين عبدالمجيد حسن National ID: 29005272100781	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



تأليف د. محمد عبد الرحمن بن عبد الوهاب
بمطبعة تحقيق المخطوطات

plan

٢٨ صلاح الدين الشيرازي

السلام - الجيزة

0-5 VV C-0
6311

 Δ^2 

78...0TYT1...VA1

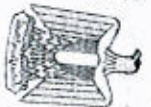
حاصلة على ليسانس (د.ا.ب)

میترو جہ

1

کمال طلعت بعد جاد

الطاقة سارية حتى ٠٧/٠٨/٢٠١١





مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

البنية التحتية
للصحة
مصر

٤٥٢

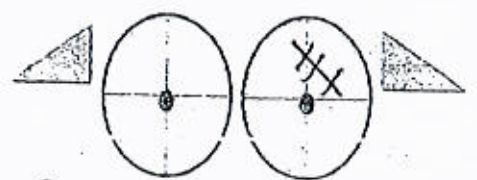
٢٠٢١

MDT FORM

28/6/2022 ١٠٠٥٢٢١٩٠

Name	د. سعاد الدسوقي	MRN	٢٠٢١/٤٥٢
Age		ID	٤٩٠٠٥٤٧٢١٠١١
Menopausal status		Phone	٠١١٤٩٧٧٧٢٣٠
OCP		marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx:	IDC GII				R	L	
ER:	6/8	PR:	8/8	HER 2:	34	KI67:	
Sonogramography:	CT2 - No → NACT. TcHP X 6 cycles → BCS. 6/2022						
Mets Workup:	Lt. BCS + SLNBX → 8/6/22 TNM						

Recommendations:
IDC GII
SLNBX 0/3
Free margins + Partial pathological response
ypT1b ypNo

MDT OUTCOME & PLAN

For TDM,
PORT 1 A-I / Zoladex

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
SNP		ORP	

28/6/2022

Angela Sh... 28/6/2022

28/6/2022



Patient Name: Sama Alaa Al Din Abd Al Maguid Hassan	Date : 11/01/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 28 Year(s)
Medical ID: 4530/2021	Pat. ID: 10712

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had CBS in left breast.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C)
- No right breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Left breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed left breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no right breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Nehal Hamdy

11/01/2023 4:12 PM

Patient Name	: الأستاذ / سماء علاء الدين عبدالمجيد حسن	Request No.	: 132727
Patient No.	: 29005272100781	Request Date	: 26/10/2021
Path No.	: SR-559/21	Verification Date	: 31/10/2021
Sex	: Female	Financial Category	: أوراء دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 31 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :			

Pathology Report

Clinical Data:
Lt breast cancer

Nature of the specimen:
Slide revision

Gross Examination:
One block (7813/21), & three immunostained slides.

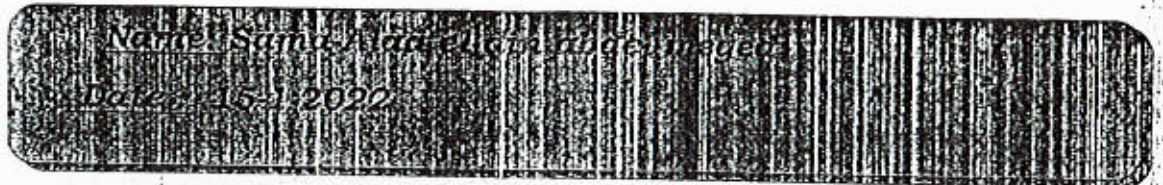
Microscopic examination:
• Histological type: IDC
• Grade II
• Angioinvasion: no
• Ductal carcinoma in situ: no

Diagnosis:
Lt breast cancer, slide revision:
Invasive duct carcinoma GII
• Biomarkers:
o ER: moderate nuclear reaction in 40% of tumor cells (Allred score 6/8)
o PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
o Her2: Strong complete membrane reaction in > 10% of tumor cells (score 3+)

Prof. Gamal Abdelaty
Dr. Rana Fathy



سليم



POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

**** Given history of breast cancer**

1. Chest:

- Left breast UOQ , irregular parenchymal mass is seen measuring about 2.6 x 2.4 cm.
- Prominent left axillary LN is seen measuring about 1.3 x 0.9 cm.
- Right upper lobe, two tiny pulmonary nodules are noted (one of them is calcified)
- Otherwise, No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Right thyroid nodule is seen measuring 5 mm.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Bilateral adnexal cysts are noted, likely functional , for follow up.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy or collections.
- No suspicious lytic or sclerotic bone lesions.

OPINION:

- Left breast UOQ , irregular parenchymal mass lesion with prominent left axillary lymph node, for sono-mammographic correlation.
- Right upper lobe, two tiny pulmonary nodules, likely benign. No definite pulmonary metastatic deposits.
- No hepatic focal lesions.

Dr.m.gomaa;md



Patient Name: Samaa Aladeeldeen Abdelhamid

Date: 23/12/2021

Tc-99m MDP bone scan.

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique:

Delayed Anterior and posterior whole body scan 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP.

Delayed Static Phase:-

- Warm tracer uptake is noted upper sternal body for CT correlation and follow up to exclude more serious nature.
- Degenerative changes are noticed over dorsal and lumbar vertebrae.
- Arthritic changes at knees, shoulders .
- Left hip replacement status.
- Both kidneys are seen.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits, however follow up bone scan is recommended as described.

Thanks for reference

*Nuclear medicine Unit
Huda Fathy , M.D*